

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

EVMAC · ESCALA PARA LA VALORACIÓN DE LA MANÍA POR CLÍNICOS

Clinician-Administered Rating Scale for Mania – Evaluación heteroaplicada estructurada de estados maníacos y psicóticos

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial	Escala para la Valoración de la Manía por Clínicos (EVMAC / CARS-M)
Autores Originales	Edward G. Altman, D. R. Hedeker, P. G. Janicak, J. L. Peterson y J. M. Davis (1994)
Validación Española	Antoni Bulbena et al. (Grup Sant Pau, 1994); Lorenzo Livianos et al. (2000)
Tipo de Instrumento	Escala heteroaplicada de entrevista clínica semiestructurada
Población Diana	Pacientes adultos con Trastorno Bipolar en fase maníaca, hipomaníaca o mixta
Tiempo de Aplicación	15 a 25 minutos (15 reactivos valorados por un psiquiatra o psicólogo)
Formato de Respuesta	Escala tipo Likert clínica de 6 puntos: 0 (Ausente) a 5 (Extremo / máxima gravedad)
Finalidad Clínica	Cuantificación precisa de la severidad del episodio maníaco, disociación de síntomas maníacos nucleares versus síntomas psicóticos y monitorización de respuesta a eutimizantes y antipsicóticos

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

A diferencia de escalas de manía más escuetas como la Young Mania Rating Scale (YMRS), la CARS-M (validada en España bajo las siglas EVMAC) fue diseñada expresamente para resolver una limitación psicométrica recurrente en los ensayos clínicos de trastorno bipolar: la mezcla confusa entre los síntomas afectivo-motores del núcleo maníaco y los síntomas psicóticos floridos (delirios de grandeza o persecutorios y alucinaciones).

El modelo teórico de Altman et al. bifurca con nitidez el episodio maníaco en dos dimensiones ortogonales clínicamente diferenciables: a) **Subescala de Manía Nuclear**, que explora euforia expansiva, aceleración del curso del pensamiento (fuga de ideas), aumento de energía física, reducción de la necesidad biológica de sueño, desinhibición sexual e hiperactividad orientada a metas; y b) **Subescala de Psicosis**, que evalúa formalmente delirios de grandeza mesiánica, delirios paranoides/persecutorios, alucinaciones auditivas y extrañeza del pensamiento. Esta disociación permite ponderar con precisión la necesidad de terapia combinada con antipsicóticos atípicos.

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Subescala Clínica	Nº Ítems	Ítems Constituyentes y Manifestaciones Evaluadas
Manía Nuclear	10 ítems	Ítems 1 a 10: Euforia, irritabilidad, energía desmedida, verborrea, fuga de ideas, insomnio, hiperactividad motora, grandiosidad afectiva, compras impulsivas y juicio social.
Psicosis / Delirios	5 ítems	Ítems 11 a 15: Delirios de grandeza clínica, ideas delirantes paranoides/referenciales, alucinaciones sensoriales, desorganización conceptual y falta de insight psicótico.
EVMAC Total Compuesta	15 ítems	Suma global de los 15 reactivos (Rango: 0 a 75 puntos).

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMACIÓN Y REGLAS DE CORRECCIÓN · EVMAC

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATINOAMÉRICA

Consistencia Interna	Alfa de Cronbach de 0.88 a 0.93 en estudios multicéntricos en España (Bulbena et al., 1994; Livianos et al., 2000). Subescala de Manía = 0.89; Subescala de Psicosis = 0.84.
Fiabilidad Inter-Jueces	Coefficiente de correlación intraclase (ICC) = 0.91 a 0.95 entre clínicos psiquiatras tras entrenamiento estructurado.
Validez Concurrente	Correlación excelente con la Young Mania Rating Scale (YMRS, $r = 0.91$) y la Bech-Rafaelsen Mania Scale (MAS, $r = 0.88$).
Sensibilidad al Tratamiento	Detecta precozmente el descenso en la fuga de ideas y la agitación psicomotriz inducido por fármacos estabilizadores del ánimo (litio, valproato) y antipsicóticos atípicos.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

- Calificación Heteroaplicada de 0 a 5:** Cada ítem dispone de anclajes clínicos descriptivos rigurosos: 0 = Ausente; 1 = Dudoso / mínimo; 2 = Leve; 3 = Moderado; 4 = Grave; 5 = Extremo / altamente incapacitante.
- Cálculo de Subescalas:**
 - Subescala de Manía Nuclear:** Suma de ítems 1 a 10 (Rango: 0 a 50).
 - Subescala de Psicosis:** Suma de ítems 11 a 15 (Rango: 0 a 25).
- Puntuación Total:** Suma de los 15 reactivos (Rango: 0 a 75).
- Criterio de Remisión Clínica:** Se considera remisión del episodio maniaco una puntuación total en EVMAC ≤ 8 mantenida de forma estable.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación Total	Estratificación	Perfil Clínico	Intervención y Nivel Asistencial
0 a 8 puntos	Remisión / Eutimia	Asintomático	Mantenimiento preventivo con eutimizante oral.
9 a 15 puntos	Hipomanía Leve	Sin psicosis	Ajuste de dosis ambulatorio; evitar estimulantes.
16 a 25 puntos	Manía Moderada	Compromiso funcional	Intensificación farmacológica ambulatoria o hospital de día.
26 a 75 puntos	Manía Grave / Psicótica	Agitación / Delirios	Ingreso hospitalario en Unidad de Agudos de Psiquiatría.

CRITERIO CLÍNICO DE PSICOSIS MANÍACA: Cualquier puntuación mayor o igual a 3 en cualquiera de los ítems 11 al 14 confirma la presencia de síntomas psicóticos congruentes o incongruentes con el estado de ánimo, lo que obliga legal y clínicamente a valorar la hospitalización psiquiátrica involuntaria urgente en caso de falta de insight y riesgo conductual.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y DIRECTRICES · EVMAC

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

Paso 1: Entrevista Heteroaplicada: Conducida por el facultativo integrando la información del paciente y de informantes familiares clave.

Paso 2: Conducta Terapéutica Asistencial:

- **Si EVMAC $\leq$ 8:** Fase eutímica confirmada. Mantener controles de litemia o valproemia en rango terapéutico.
- **Si EVMAC 9-15 (Hipomanía):** Optimizar dosis de estabilizador del ánimo; suspender de inmediato cualquier antidepresivo en curso para frenar el viraje afectivo.
- **Si EVMAC $\geq$ 16 con subescala de Psicosis $\geq$ 3:** Manía psicótica severa. Iniciar de inmediato tratamiento combinado: Estabilizador del estado de ánimo (Litio o Valproato) + Antipsicótico de segunda generación (Olanzapina, Quetiapina o Aripiprazol). Garantizar entorno seguro e internamiento si hay riesgo para terceros o dilapidación patrimonial.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO (VIGNETTE)

Identificación: Varón de 38 años, diagnosticado de Trastorno Bipolar Tipo I, trasladado al servicio de urgencias por los servicios de emergencias y escoltado por fuerzas de seguridad tras irrumpir en una sucursal bancaria proclamando haber recibido una revelación divina para condonar las deudas de la ciudad.

Evaluación Inicial en EVMAC: Total = 46 / 75 puntos (Manía Psicótica Grave).

- **Subescala Manía Nuclear:** 32 / 50 puntos. Euforia e irritabilidad extrema (ítem 1 = 4), habla ininterrumpida y acelerada (ítem 4 = 4), insomnio sin fatiga de 72 horas de evolución (ítem 6 = 5) y donación impulsiva de todas sus pertenencias.
- **Subescala Psicosis:** 14 / 25 puntos. Delirio megalomaniaco mesiánico irreductible (ítem 11 = 5) y falta total de conciencia de enfermedad (ítem 15 = 4).

Manejo Hospitalario: Se gestionó ingreso involuntario en Unidad de Agudos de Psiquiatría. Se pautó carbonato de litio (titulado a litemia de 0.9 mEq/L) combinado con olanzapina 20 mg/día y clonazepam transitorio para el control motor. A los 14 días de ingreso, la puntuación total en EVMAC descendió a 12 puntos, remitiendo completamente las ideas delirantes mesiánicas y restableciéndose un ciclo circadiano de sueño de 7 horas diarias.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALERTAS CLÍNICAS Y LEGALES

- La desinhibición maniaca extrema con gastos desmedidos o promiscuidad exige medidas legales urgentes de protección patrimonial cautelar.
- El agotamiento físico por hiperactividad e insomnio pertinaz puede provocar colapso hemodinámico y deshidratación grave.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- **Manía Inducida por Tóxicos:** Descartar intoxicación por cocaína, anfetaminas o fármacos esteroideos mediante cribado toxicológico.
- **Trastorno Esquizoafectivo:** Síntomas psicóticos que persisten más de dos semanas en ausencia de síntomas afectivos mayores.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Altman, E. G., Hedeker, D. R., Janicak, P. G., Peterson, J. L., & Davis, J. M. (1994). The Clinician-Administered Rating Scale for Mania (CARS-M): Development, reliability, and validity. *Biological Psychiatry*, 36(2), 124–134.
- Bulbena, A., Martín-Santos, R., & Grupo Sant Pau. (1994). Adaptación y validación española de la Escala para la Valoración de la Manía por Clínicos (EVMAC). *Actas Luso-Españolas de Neurología, Psiquiatría y Ciencias Afines*, 22(4), 167–174.
- Livianos, L., Rojo, L., & Vila, M. (2000). Validación de la versión española de la escala CARS-M para la evaluación de episodios maníacos. *Actas Españolas de Psiquiatría*, 28(3), 169–176.
- Young, R. C., Biggs, J. T., Ziegler, V. E., & Meyer, D. A. (1978). A rating scale for mania: Reliability, validity and sensitivity. *British Journal of Psychiatry*, 133(5), 429–435.